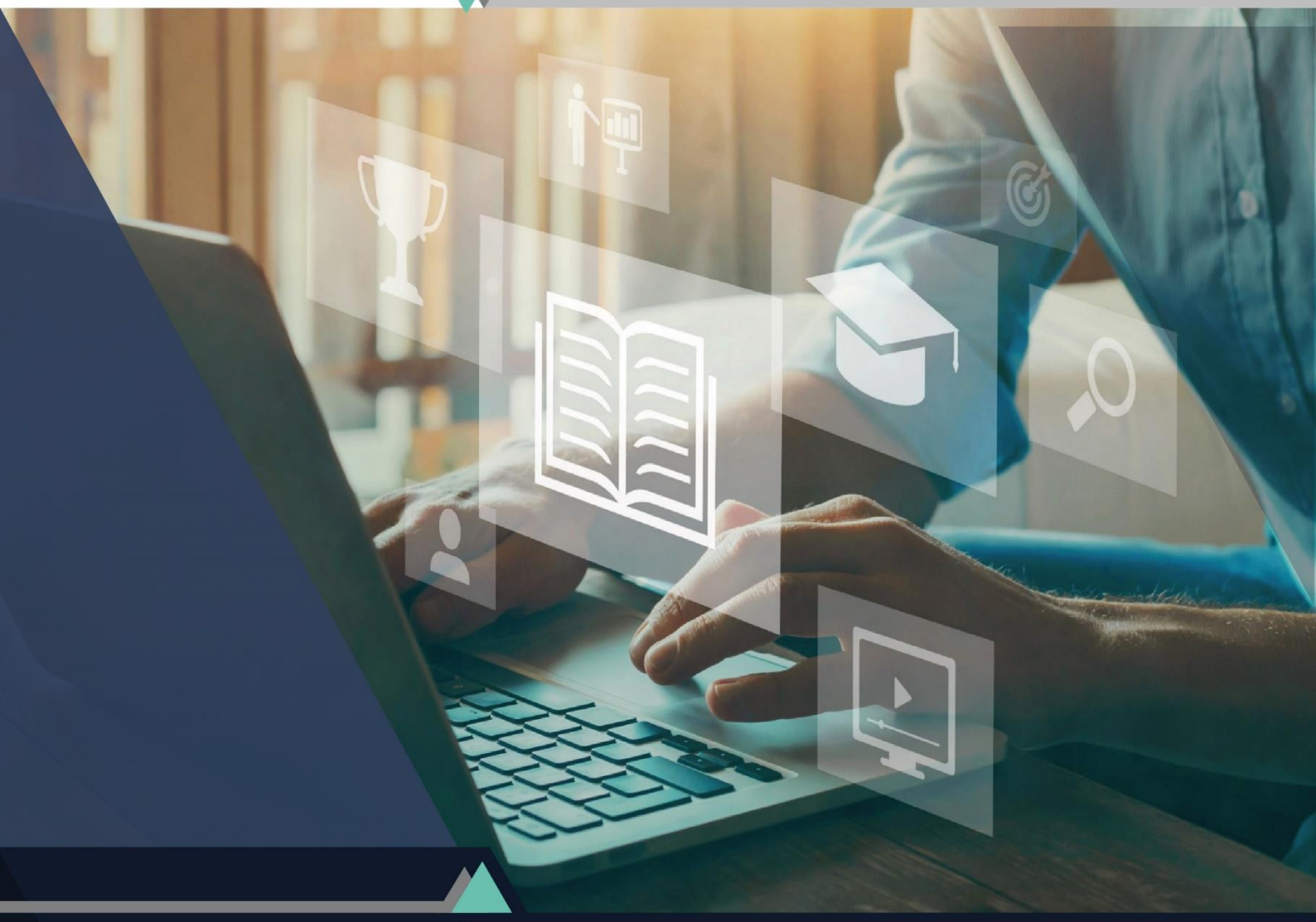


Benefícios por Incapacidade, Perícia Médica e Auxílio-Acidente

Autoria: ***Victor César de Carvalho***

Disciplina: Benefícios por Incapacidade, Perícia Médica e Auxílio-Acidente

Título do tema: Benefícios por Incapacidade e o Papel da Perícia Médica

Autoria: Victor César de Carvalho

Leitura crítica: leitor, insira aqui seu nome completo

Objetivos

- Compreender os fundamentos legais dos benefícios por incapacidade no RGPS.
- Identificar os critérios periciais e documentais exigidos para a concessão dos benefícios.
- Analisar os aspectos práticos da atuação do advogado previdenciarista diante da perícia médica, indeferimentos e reativações.
- Reconhecer os efeitos jurídicos da reabilitação, do limbo previdenciário e da perda da qualidade de segurado.
- Entender as limitações e possibilidades de acumulação entre benefícios, especialmente no caso do auxílio-acidente.

1. Introdução

O sistema previdenciário brasileiro garante proteção aos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em situações de perda da capacidade laborativa, por meio da concessão de benefícios por incapacidade. Esses benefícios são classificados conforme a natureza e duração da incapacidade, sendo fundamentais para a proteção social e a subsistência do trabalhador.

Não basta, porém, o simples diagnóstico de uma doença ou lesão. A concessão do auxílio por incapacidade temporária, da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio-acidente depende da **comprovação de que o quadro clínico impacta, de forma parcial ou total, temporária ou permanente, a capacidade para o trabalho**. Essa análise será realizada pelo INSS por meio de perícia médica oficial ou, quando cabível, pela avaliação da documentação médica apresentada.

Nesse contexto, o papel do **advogado previdenciarista** se torna central: cabe a ele orientar o segurado desde a elaboração do requerimento até a eventual judicialização do caso, organizando os documentos essenciais, acompanhando perícias e redigindo quesitos, além de atuar estrategicamente quando há indeferimento, cessação indevida ou necessidade de restabelecimento.

Diante disso, esta leitura digital se propõe a abordar de forma didática e aprofundada os principais aspectos legais, normativos e práticos relacionados aos benefícios por incapacidade, de forma alinhada ao conteúdo das aulas e às questões de avaliação da disciplina. O objetivo é garantir ao aluno não apenas a compreensão teórica, mas também o domínio da aplicação prática desses conhecimentos na advocacia previdenciária contemporânea.

2. Introdução aos Benefícios por Incapacidade

Os benefícios por incapacidade no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) têm como objetivo principal amparar o segurado que perde, total ou parcialmente, de forma temporária ou definitiva, a capacidade para o exercício de atividade laborativa. Essa proteção é assegurada por três espécies distintas de benefícios: auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio-acidente.

Para que qualquer um desses benefícios seja concedido, não basta a existência de uma doença: é imprescindível a comprovação de que tal condição compromete a aptidão do segurado para o trabalho, seja no momento da análise administrativa ou judicial. Trata-se, portanto, de um conceito jurídico associado à realidade funcional do segurado, e não apenas a um diagnóstico clínico.

A classificação da incapacidade adotada pela legislação previdenciária é essencial para definir o tipo de benefício a ser concedido. Podemos assim dividi-la:

- Temporária: quando há previsão de recuperação.
- Permanente: quando não há perspectiva de restabelecimento da capacidade laborativa.
- Total: quando o segurado está incapacitado para toda e qualquer atividade profissional.
- Parcial: quando há redução da capacidade apenas para a função habitual, mantendo aptidão para outras atividades.
- Laboral: quando a causa da incapacidade está diretamente relacionada ao exercício da atividade profissional.

- Não laboral: quando decorre de fatores externos à atividade, como doenças comuns ou acidentes domésticos.

Essas classificações são fundamentais para o enquadramento do benefício e para a correta atuação técnica do advogado. Por exemplo, uma limitação auditiva parcial e definitiva pode não gerar aposentadoria, mas sim um auxílio-acidente, se houver redução da capacidade habitual. Já uma doença psiquiátrica de difícil estabilização pode fundamentar pedido de aposentadoria, mesmo sem internação prévia, se comprovada a irreversibilidade funcional.

2. 1 Fundamentos

Os benefícios por incapacidade estão regulamentados pela:

- Lei nº 8.213/91 – especialmente artigos 59 a 63
- Instrução Normativa INSS nº 128/2022
- Decretos nº 3.048/1999 e 10.410/2020

Além disso, a análise pericial ou documental deve sempre observar o princípio da verdade material, cabendo ao INSS buscar a realidade dos fatos mesmo que não expressamente declarados no requerimento.

2. 2 Qualidade de segurado e carência

São **requisitos indispensáveis** para a concessão dos benefícios:

- **Qualidade de segurado ativa no momento da incapacidade**, exceto em casos especiais como reativação por decisão judicial.
- **Cumprimento da carência de 12 contribuições mensais**, salvo exceções previstas legalmente (como acidente de qualquer natureza, doenças especificadas na Portaria Interministerial MTP/MS nº 22/2022, entre outras).

É comum o indeferimento de benefícios por falta de carência, mesmo quando ela **já foi cumprida anteriormente**, mas **não corretamente identificada no CNIS**. Casos assim exigem atenção minuciosa por parte do advogado previdenciarista.

2. 1 Conectando com a prática:

A atuação do advogado previdenciarista exige **olhar treinado para inconsistências e omissões do INSS**, como:

- Laudos incompletos (sem CID, carimbo ou prazo de afastamento);

- Contribuições feitas por MEI ou segurado especial que não constam no sistema;
- Perícias mal fundamentadas ou superficiais;
- Situações de limbo previdenciário que podem ser confundidas com abandono de emprego.

Esses são pontos explorados em várias questões do nosso Banco de Questões, como nos temas de qualidade de segurado, exceção de carência e interpretação técnica da perícia.

3. Auxílio por Incapacidade Temporária

O auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) é o benefício devido ao segurado que estiver **temporariamente incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual**, por mais de 15 dias consecutivos, desde que preenchidos os requisitos legais e comprovada a situação incapacitante.

3.1 Requisitos legais

Conforme o art. 59 da Lei nº 8.213/91, são exigidos os seguintes critérios para sua concessão:

- **Qualidade de segurado ativa** no momento da incapacidade;
- **Carência de 12 contribuições mensais**, salvo nas hipóteses de dispensa previstas no art. 26, II, da mesma Lei (como nos casos de acidente de qualquer natureza e doenças listadas na Portaria Interministerial MTP/MS nº 22/2022);
- **Comprovação da incapacidade laboral**, por perícia médica do INSS ou análise documental válida.

3.2 Documentação médica e análise documental

Com base no art. 387 da Instrução Normativa INSS nº 128/2022, o atestado médico apresentado para análise documental deverá conter:

- Nome completo do paciente;
- Data de emissão;
- CID (Classificação Internacional de Doenças);
- Tempo estimado de afastamento;
- Assinatura, carimbo e número do CRM do profissional emissor.

A ausência de qualquer um desses elementos pode gerar **indeferimento automático do pedido**, o que exige atuação preventiva e atenta por parte do advogado.

Além disso, **o laudo deve ser recente**: geralmente aceitam-se documentos com até 30 dias de emissão, conforme práticas administrativas usuais e respaldo do art. 60, §4º da Lei nº 8.213/91.

3.3 Pedido de prorrogação (PP)

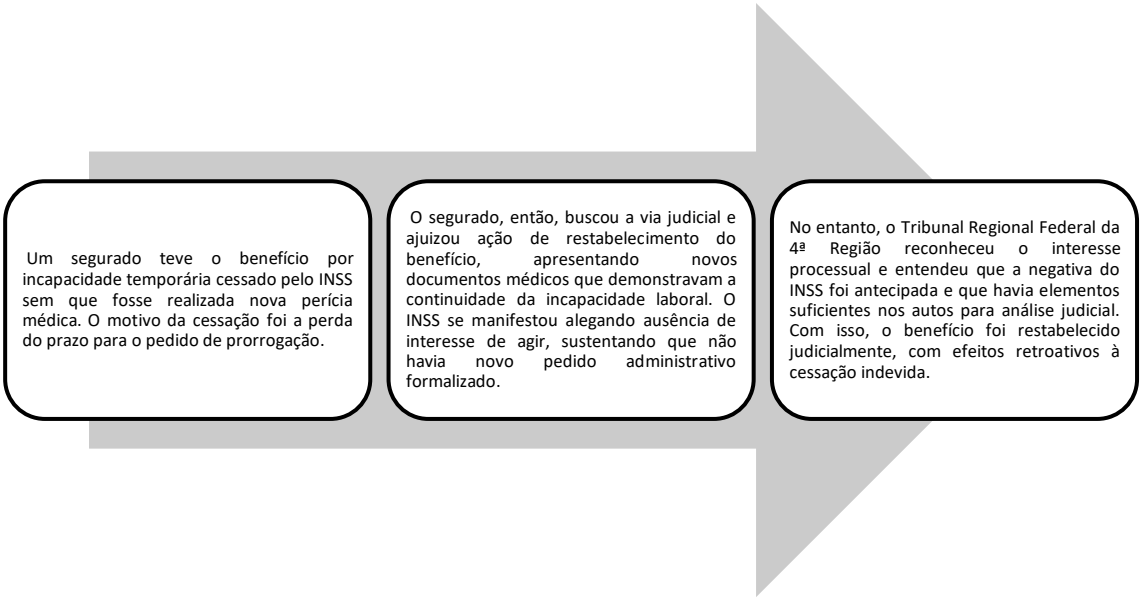
O pedido de prorrogação do benefício deve ser realizado pelo segurado **até 15 dias antes da data de cessação do benefício (DCB)**, conforme o §3º do art. 339 da IN nº 128/2022.

Segundo a **Portaria Conjunta PRES/INSS/SRGPS/MPS nº 38/2023**:

- Se a espera da perícia for **inferior ou igual a 30 dias**, o atendimento é agendado com base na DCB;
- Se a espera for **superior a 30 dias**, o benefício é **automaticamente prorrogado por mais 30 dias**, sem nova perícia (limitado a 2 prorrogações automáticas).
- O segurado poderá **solicitar o encerramento do benefício** se se considerar apto, sem necessidade de nova avaliação presencial, pelo app Meu INSS ou Central 135.

Box: Conectando à Realidade – Exemplos Práticos

Este espaço tem como finalidade ilustrar a aplicação concreta dos conteúdos abordados nesta Leitura Digital, reforçando o vínculo entre a teoria estudada e as situações que ocorrem no dia a dia da advocacia previdenciária. A intenção é demonstrar como os conhecimentos jurídicos, normativos e estratégicos são essenciais para a solução de casos reais, fortalecendo o olhar crítico e prático do aluno.



Fonte: elaborada pelo autor.

3.4 Reativação e cessação retroativa

É comum que o benefício seja **concedido com data de cessação anterior à data da perícia**, o que pode gerar um benefício já cessado no momento da concessão. Nesses casos, o advogado deve avaliar:

- A viabilidade de apresentar **pedido de prorrogação**, mesmo após a cessação (havendo interesse de agir, conforme jurisprudência recente);
- A possibilidade de **novo requerimento com atestado atualizado**;
- O eventual **ajuizamento de ação judicial com pedido de restabelecimento ou de tutela antecipada**, em caso de negativa do INSS.

Esses temas foram explorados em profundidade no nosso Banco de Questões, especialmente no tocante à **atuação técnica do advogado diante de indeferimentos e cessações indevidas**, e à **interpretação da legislação infralegal mais recente**.

3.5 Limitações e vedação de atividade remunerada

Durante o gozo do benefício, o segurado **não poderá exercer atividade remunerada**. Caso o INSS detecte vínculo ativo durante o período, poderá cessar o benefício e até mesmo solicitar devolução dos valores recebidos.

3.6 Encaminhamento para reabilitação

O INSS pode **encaminhar o segurado para reabilitação profissional**, o que **impede a concessão imediata da aposentadoria por incapacidade permanente**. O plano de reabilitação é obrigatório e deve ser cumprido sob pena de suspensão do benefício.

4. Auxílio por Incapacidade Permanente

A aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que, após avaliação médica-pericial, for considerado **total e definitivamente incapaz para o exercício de qualquer atividade laboral** e **não puder ser reabilitado para outra profissão**. Esse benefício substitui a antiga "aposentadoria por invalidez".

4.1 Requisitos legais

De acordo com o art. 42 da Lei nº 8.213/91, são requisitos:

- **Incapacidade total e permanente** para o trabalho, independentemente da atividade habitual;
- **Impossibilidade de reabilitação profissional** para outra função compatível com a condição do segurado;
- **Qualidade de segurado ativa** no momento da incapacidade (com exceções discutidas judicialmente);
- **Carência mínima de 12 contribuições**, salvo em casos de isenção conforme o art. 26, II (doença grave, acidente, doenças previstas em portarias interministeriais).

A incapacidade deve ser **consolidada e irreversível**, distinguindo-se do auxílio por incapacidade temporária, no qual há perspectiva de melhora e retorno à atividade.

4.2 Regra de cálculo

Após a Reforma da Previdência (EC nº 103/2019), a regra de cálculo passou a ser:

- **60% da média de todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994**, com acréscimo de **2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição** (homens) ou 15 anos (mulheres).

4.3 Exceções com cálculo mais vantajoso:

- Nos casos de **acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho**, o valor corresponde a **100% da média salarial**, sem aplicação do redutor.

Esse aspecto foi explorado nas questões do Banco de Questões sobre cálculo da renda mensal e situações excepcionais de regra cheia.

4.4 Majoração de 25%

Conforme o art. 45 da Lei nº 8.213/91, o valor do benefício pode ser **majorado em 25%** quando o segurado aposentado **necessitar de assistência permanente de outra pessoa**, independentemente do teto previdenciário.

Essa majoração **só se aplica à aposentadoria por incapacidade permanente**, mesmo quando o valor do benefício ultrapassa o teto.

4.5 Reavaliação pericial e dispensa

Como regra, o segurado em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente deve ser submetido a **revisões periciais bienais**. No entanto, conforme o §1º do art. 101 da Lei nº 8.213/91, **estão dispensados da perícia periódica** os segurados:

- Com **60 anos ou mais**;
- Portadores do vírus HIV;
- Com **55 anos ou mais e que já estejam em benefício por mais de 15 anos**, excetuadas hipóteses de irregularidade.

Esse ponto foi tratado diretamente em questão que envolvia associação entre hipóteses de dispensa e situação pericial.

4.6 Revisão e cancelamento

O benefício pode ser **revisto de ofício pelo INSS** ou a pedido do segurado, mediante nova perícia. Também pode ser cancelado se for constatada a **recuperação da capacidade laboral** ou se houver **retorno voluntário ao trabalho**.

Em algumas situações, após a cessação do benefício, o segurado poderá receber uma **mensalidade de recuperação**, calculada proporcionalmente à sua nova renda, se retornar gradualmente à atividade profissional.

5. Auxílio-Acidente

O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, **pago ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza**, apresentar **redução permanente da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual**, ainda que continue trabalhando.

Diferentemente dos demais benefícios por incapacidade, **não exige afastamento total do trabalho**. É possível que o segurado continue exercendo atividades laborativas com limitação funcional.

5.1 Requisitos para concessão

Conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91, são requisitos para concessão:

- Ter qualidade de segurado na data do acidente ou da consolidação das lesões;
- Sofrer acidente de qualquer natureza (laboral ou não laboral);
- Apresentar **redução permanente da capacidade funcional** para a atividade habitual;
- Ser **empregado urbano ou rural, trabalhador avulso, doméstico ou segurado especial**.

Importante: Contribuinte individual e facultativo **não têm direito** ao auxílio-acidente.

5.2 Características principais

- Possui **natureza indenizatória** (não substitutiva da renda);
- **Pode ser acumulado com remuneração**, já que não exige afastamento do trabalho;
- Valor fixado em **50% do salário de benefício**;
- **Inicia-se no dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária**, quando este tiver sido concedido, ou a partir da consolidação das lesões.

Esses pontos foram base para questões sobre valor, natureza e exigência de afastamento.

5.3 Acumulações e vedações

Segundo o §2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e jurisprudência consolidada:

- É **vedada a acumulação de dois auxílios-acidente**, mesmo que referentes a acidentes distintos.
- É **incompatível com o BPC/LOAS**, pois este não admite cumulação com nenhum benefício previdenciário.
- Não pode ser **cumulado com benefício por incapacidade temporária ativo**.
- Só é **cumulável com aposentadoria** nos casos em que ambos os benefícios **foram concedidos antes de 11/11/1997**, conforme **Súmula 507 do STJ**.

Essas condições foram amplamente exploradas no Banco de Questões, inclusive com pegadinhas envolvendo segurado especial, reingresso, e datas de início de aposentadoria.

5.4 Auxílio-acidente e contagem como carência

De acordo com a Portaria MTP nº 991/2022, o período de percepção de auxílio-acidente **pode contar como carência**, desde que intercalado com períodos de contribuição ou atividade.

5.5 Revisão do benefício

O valor do auxílio-acidente pode ser revisado **em caso de erro material no cálculo inicial** ou **quando houver agravamento do quadro clínico**, que justifique a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

5.6 Atuação do advogado

O advogado previdenciarista deve estar atento a:

- Exigência da documentação correta para comprovação da redução da capacidade;
- Apresentação de provas técnicas robustas em caso de negativa administrativa;
- Apontamento de violação ao direito adquirido ou erro de cálculo no valor do benefício;
- Identificação de acúmulo indevido de benefícios ou indeferimentos baseados em categoria de segurado equivocada.

6. A Perícia Médica e a Atuação Estratégica do Advogado Previdenciarista

A **perícia médica** é o principal instrumento de avaliação utilizado pelo INSS para constatar a existência e a extensão da incapacidade laborativa. Sua função técnica deve observar os princípios da **veracidade, objetividade e adequação ao caso concreto**.

Contudo, na prática, é comum que laudos venham incompletos, contraditórios ou superficialmente fundamentados. Por isso, o advogado previdenciarista deve dominar todos os aspectos que envolvem essa etapa do processo.

6.1 Acompanhamento em perícia e quesitação

O acompanhamento do cliente na perícia judicial é permitido e estratégico. Embora o advogado não possa intervir durante o exame, sua presença garante segurança ao segurado e possibilita posterior análise crítica do procedimento.

Além disso, o advogado pode elaborar **quesitos periciais**, que são perguntas técnicas enviadas ao perito para esclarecer pontos essenciais como:

- Data provável de início da incapacidade (DII);
- Prognóstico de recuperação;

- Compatibilidade do quadro clínico com as atividades habituais;
- Relação entre a doença e a atividade profissional.

Esses elementos apareceram em várias questões do Banco de Questões, testando a habilidade do aluno em diferenciar a atuação técnica pré e pós-pericial.

6.2 Impugnação do laudo pericial

Quando o laudo judicial é desfavorável, mas apresenta **inconsistências técnicas, ausência de resposta a quesitos ou análise superficial**, o advogado pode apresentar **impugnação fundamentada**, requerendo nova perícia ou esclarecimentos.

6.3 Recurso administrativo e reativação de benefício

Em caso de indeferimento administrativo, é possível apresentar **recurso administrativo no prazo de 30 dias** (art. 579 da IN nº 128/2022). No entanto, **não se recomenda essa via como primeira alternativa**, pois os recursos administrativos costumam demorar excessivamente para análise e decisão. Para garantir **maior celeridade e efetividade na concessão do benefício**, recomenda-se a **judicialização do pedido**, especialmente quando já houver documentação médica robusta ou negativa administrativa injustificada.

6.4 Tutela antecipada e restabelecimento judicial

Na via judicial, é possível requerer **tutela antecipada para restabelecimento imediato do benefício**, desde que haja prova robusta da incapacidade e urgência no provimento. O pedido pode ser fundamentado em atestados recentes, laudos particulares, exames e declaração de ausência de renda.

6.5 Novo requerimento após improcedência

Mesmo após decisão judicial improcedente com trânsito em julgado, é possível novo pedido administrativo, **desde que com novos elementos de prova ou agravamento do quadro clínico**, conforme o art. 571 da IN nº 128/2022. O advogado deve orientar o cliente sobre a documentação adequada e os riscos de indeferimento por ausência de interesse de agir.

7. Conclusão

O estudo dos benefícios por incapacidade exige do operador do Direito Previdenciário não apenas conhecimento teórico das normas, mas também sensibilidade prática diante das fragilidades enfrentadas pelos segurados em situação de vulnerabilidade. A compreensão das classificações da incapacidade, dos requisitos legais e das possibilidades de atuação estratégica permite ao profissional identificar com precisão a melhor via — administrativa ou judicial — para garantir o direito ao benefício.

Além disso, os temas tratados nesta leitura, como reabilitação, limbo previdenciário, impugnação de laudo, acúmulo indevido e revisão de benefícios, revelam a complexidade da matéria e a importância de um olhar técnico e atento aos detalhes.

Dessa forma, espera-se que o aluno, ao concluir este material, esteja apto a compreender os fundamentos normativos, reconhecer as situações práticas mais recorrentes e desenvolver uma atuação previdenciária mais segura, propositiva e alinhada com a jurisprudência e as diretrizes administrativas atuais.

Referências

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 05 maio. 2025.

BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 05 maio. 2025

BRASIL. Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm. Acesso em: 05 maio. 2025.

BRASIL. Decreto nº 10.410, de 30 de junho de 2020. Altera o Regulamento da Previdência Social. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.410-de-30-de-junho-de-2020-264529054. 05 maio. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Instrução Normativa PRES/INSS nº 128, de 28 de março de 2022. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-pres/inss-n-128-de-28-de-marco-de-2022-393054196. 05 maio. 2025.

BRASIL. Portaria Interministerial MTP/MS nº 22, de 31 de agosto de 2022. Estabelece a lista de doenças que isentam de carência para benefícios por incapacidade. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/ms-n-22-de-31-de-agosto-de-2022-429182984. Acesso em: 05 maio. 2025.

BRASIL. Portaria Conjunta PRES/INSS/SRGPS/MPS nº 38, de 30 de outubro de 2023. Dispõe sobre os procedimentos de prorrogação automática. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-pres/inss/srgps/mps-n-38-de-30-de-outubro-de-2023-519261431. Acesso em: 05 maio. 2025.

BRASIL. Portaria MTP nº 991, de 22 de março de 2022. Dispõe sobre o reconhecimento de períodos como carência. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-991-de-22-de-marco-de-2022-390685923. Acesso em: 05 maio. 2025.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. Acórdão – Restabelecimento de Auxílio – Falta de PP – Interesse de Agir – Concedido após DCB. Documento anexo ao material da disciplina. Acesso em: 05 maio. 2025.